

Intervenant 3 — Texte à lire

Parties 5 & 6 · Services, automatisation & conclusion · slides 12 à 18 · durée cible ~ 5 min 10

Slide 12 / 18 — Ordonnances & documents

~ 0:47

Poursuivons. Pour nous, une consultation ne se termine pas quand le médecin referme le dossier : elle se termine quand le patient repart avec un vrai document en main. Et c'est exactement ce que CuraMedical produit, tout seul. Le médecin saisit son ordonnance de façon structurée : pour chaque médicament, la dose et la durée. À partir de cette saisie, l'ordonnance est générée automatiquement en PDF, avec le cachet et la signature du médecin déjà intégrés — le document est prêt à imprimer ou à envoyer. Les comptes-rendus de consultation suivent exactement la même logique et sont eux aussi exportés en PDF. On passe donc de la saisie à un document propre et professionnel en un seul clic, sans jamais rien retaper, et surtout sans risque d'erreur de recopie.

Slide 13 / 18 — Téléconsultation

~ 0:37

Mais tous les patients ne peuvent pas se déplacer jusqu'au cabinet — par distance, ou par difficulté à se déplacer. Alors, plutôt que de faire venir le patient, CuraMedical amène le cabinet jusqu'à lui, grâce à la téléconsultation. La visioconférence est intégrée directement dans la plateforme via Jitsi : il n'y a rien à installer. Pour chaque rendez-vous à distance, une salle privée est créée automatiquement, et pendant l'appel, le médecin prend ses notes en direct. L'accès aux soins n'est plus une question de kilomètres.

Slide 14 / 18 — Chatbot IA

~ 0:41

Maintenant, posons-nous une question toute simple : pour savoir combien de patients ont un rendez-vous aujourd'hui, faut-il vraiment cliquer à travers cinq écrans ? Nous avons décidé que non. Nous avons donc ajouté un chatbot qui permet d'interroger le cabinet en langage naturel. On tape sa question en français courant — « combien de patients avons-nous ? », « quels sont les rendez-vous d'aujourd'hui ? » — et la réponse arrive immédiatement, calculée sur les vraies données de l'application. Ce chatbot s'appuie sur un grand modèle de langage, via Groq. C'est donc une deuxième utilisation de l'IA dans le projet : non plus pour le diagnostic, mais pour fluidifier la gestion de tous les jours.

Pour la communication avec le patient, nous avons fait un constat tout simple : un beau site web, ce n'est utile que si le patient sait s'en servir. Or tout le monde n'est pas à l'aise pour se connecter à un site et naviguer dans une interface — je pense en particulier aux personnes âgées. Nous avons donc décidé d'aller chercher le patient là où il se trouve déjà, sur l'application que tout le monde sait utiliser : WhatsApp. Concrètement, le patient reçoit ses rappels de rendez-vous automatiquement, ce qui évite énormément d'oublis, et il peut même recevoir son ordonnance directement sur son téléphone. Le tout est orchestré par un scénario automatique construit avec n8n et relié à Twilio. Le résultat est double : moins de rendez-vous manqués pour le cabinet, et un patient mieux suivi, plus rassuré — sans qu'il ait quoi que ce soit à apprendre.

Et le patient, justement, n'est plus un simple spectateur de son suivi : il en devient acteur. Depuis son espace personnel, il peut s'inscrire en ligne, consulter ses prochains rendez-vous, retrouver ses consultations et ses ordonnances, et gérer ses informations. Il dispose ainsi, à tout moment et où qu'il soit, d'une vue claire sur son parcours de soins. Et là, la boucle est complète : de la secrétaire au médecin, et du médecin jusqu'au patient.

Avant de conclure, un mot sur les difficultés rencontrées — parce qu'un projet, ce sont aussi des obstacles qu'on apprend à franchir. Côté IA, le plus délicat a été d'aligner un jeu de données en anglais avec une saisie en français. Côté sécurité, il fallait cloisonner les données par rôle, sans pour autant rendre l'application pénible à utiliser. Pour les documents, produire des PDF à la fois lisibles et réutilisables nous a demandé plusieurs essais. L'automatisation des envois nous a poussés à découpler les tâches avec Celery, n8n et Twilio, pour ne jamais bloquer l'application. Enfin, faire tourner ensemble plusieurs services conteneurisés, et garder une interface claire malgré quatre profils différents, ont été de vrais défis. Chacun a été analysé, puis résolu — et c'est très honnêtement ce qui nous a le plus fait progresser.

Pour conclure. Nous sommes partis d'un problème concret — un cabinet désorganisé, sans aucune aide à la décision — et nous avons abouti à une plateforme complète et réellement fonctionnelle : quatre rôles bien séparés et sécurisés, une intelligence artificielle véritablement opérationnelle, des documents générés automatiquement, et de vraies connexions avec des outils externes. Ce projet nous a fait vivre toutes les étapes du métier d'ingénieur, de l'analyse du besoin jusqu'à la mise en service. Et nous ne comptons pas nous arrêter là : nous aimerions déployer la plateforme en production, continuer à améliorer le modèle d'IA, créer une application mobile pour les patients, et la relier à d'autres systèmes de santé. Merci beaucoup pour votre attention — nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.